Chờ đến lượt khám, người bệnh biết mình đang ở đâu?

Thiết kế trợ lý AI báo tiến độ hàng chờ trên MyVinmec

Võ Huyền Khánh Mây · K2 · lab coach, đang làm AI cho bài toán y tế (khóa luận, CarePath)

Bài tập 1 tuần · Vinmec Exploration Sprint

Khoảnh khắc: chờ đến lượt khám

- Chọn **một** khoảnh khắc, không ôm cả hành trình
- Đây là chỗ người bệnh mất nhiều thời gian nhất, và ít biết chuyện gì đang xảy ra
- Hẹp thì làm sâu được: 3 phỏng vấn, 3 phương án, thử với người thật trong một tuần
- Gần với điều mình thấy ở CarePath: khám chỉ vài phút, phần lớn là chờ

[KIỂM TRA SAU PHỎNG VẤN: lý do chọn còn đúng với P1–P3 không]

Mình đã làm gì

- **Dùng thử MyVinmec**, ghi lại làm gì, thấy gì, vướng ở đâu
- **3 phỏng vấn ẩn danh (P1–P3)** theo Mom Test: hỏi chuyện đã xảy ra, không hỏi ý kiến
- **Journey map** và need statement theo Biodesign
- **Prototype 3 phương án A / B / C** (model GPT, dữ liệu giả lập)
- **Thử với 2–3 người**, ghi log, sửa sau mỗi lượt

Journey map và điểm đau

[CHÈN HÌNH JOURNEY MAP SAU KHI CÓ DỮ LIỆU P1–P3]

- Điểm đau 1: **[ĐIỀN SAU: điểm đau nhiều người kể nhất]**
- Điểm đau 2: **[ĐIỀN SAU]**
- Cảm xúc chỉ vẽ theo điều người kể, chỗ không có dữ liệu để trống

Insight từ 3 phỏng vấn (OBSERVED)

[ĐIỀN SAU: chỉ điền điều đã thấy, nghe, có nguồn P#]

- **[O1: ai làm gì, khi nào, hậu quả gì. Nguồn P#]**
- **[O2]**
- **[O3]**

Chỉ nói "trong 3 cuộc, n người kể...". Không nói "người bệnh Việt Nam...".

Need statement

> **Cách để người bệnh ngoại trú biết mình đang ở đâu và còn chờ khoảng bao lâu, vì sao, cho người bệnh đang chờ khám gặp sự bất định về lượt của mình.**

[CHỐT LẠI SAU P1–P3; ghi 1 trích dẫn làm căn cứ]

Không nêu giải pháp.

Prototype: 3 phương án khác nhau về cơ chế

	Cơ chế
A user-led	Người bệnh hỏi, trợ lý trả lời
B proactive	Trợ lý tự nhắn khi có thay đổi
C collaborative	Trợ lý gợi ý, người bệnh duyệt rồi mới làm

- Mọi phương án: hiện **khoảng** thay vì số phút, có nút khẩn cấp cố định
- Dữ liệu giả lập, không có dữ liệu bệnh nhân thật

[CHÈN ẢNH MÀN HÌNH A / B / C]

Thử với người dùng và mình sửa gì

[ĐIỀN SAU KHI CÓ LOG THỬ THẬT]

- Người thử làm gì, khựng ở đâu: **[...]**
- Phương án nào họ dùng đúng, phương án nào hiểu sai: **[...]**
- Mình sửa: **[trước → sau]**
- Giới hạn: n = 2–3, đủ cho quyết định thiết kế tiếp theo, **không phải "validated"**

Bài học cho Vinmec và rủi ro chính

Best practice quốc tế [ĐIỀN SAU: 3 nguồn từ 04-best-practice, mỗi nguồn 1 dòng bài học]

Rủi ro chính, cách giảm

- Báo thừa giờ thì người bệnh đi xa, lỡ lượt: hiện **khoảng, thiên dè dặt**, không số giả chính xác
- Hỏi triệu chứng: từ chối và chuyển người thật; từ khoá khẩn cấp hiện **khối đỏ** + vị trí quầy
- Người không dùng app: bảng gọi số và nhân viên vẫn giữ song song
- Dữ liệu: bản thử chỉ mock; bản thật không gửi thông tin định danh vào API bên thứ ba

Nếu có 6 tuần ở Vinmec, và mình coach K4 thế nào

Mình làm tiếp (Tuần 1–6)

- Quan sát và phỏng vấn ngay tại khoa, thêm điều dưỡng và nhân viên quầy
- Đo thời gian chờ thật (khử định danh) để kiểm tra ước tính
- Thử vòng 1 và 2 với người dùng Vinmec; đo lỡ lượt, không chỉ "hài lòng"

Mình coach K4

- Kickoff thứ Hai chốt khoảnh khắc và "thế nào là xong"; thứ Tư kiểm log thật; thứ Sáu checkpoint
- Hỏi thay vì đưa đáp án; chấm chéo theo mẫu feedback có dòng cụ thể (từ đội QA 12 người)
- Soi trích dẫn tròn trịa và log toàn lời khen